



PCMSO

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

WORK MEDICINA OCUPACIONAL LTDA



WORK MEDICINA OCUPACIONAL LTDA

Rua Visconde de Taunay, 335 - Vila Itapura -
Campinas - SP

Índice

1. INTRODUÇÃO	1
2. OBJETIVO	1
3. CAMPO DE APLICAÇÃO	1
4. DIRETRIZES	1
5. RESPONSABILIDADES	2
6. PLANEJAMENTO	2
7. DOCUMENTAÇÃO	4
8. TABELA DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	5
Unidade: CONAMORE SSL CAMA MESA E BANHO LTDA	6
Setor: GERÊNCIA/PRODUÇÃO	6
Cargo: GERENTE DE SUPRIMENTOS	6
Setor: PRODUÇÃO-CORTE DE TECIDOS	6
Cargo: CORTADOR	6
Setor: PRODUÇÃO-COSTURA	6
Cargo: COSTUREIRA	7
Setor: PRODUÇÃO-REVISÃO E EMPACOTAMENTO	7
Cargo: AUXILIAR DE PRODUÇÃO	7
Cargo: REVISOR(A)	7
Setor: QUALIDADE	7
Cargo: LÍDER DE PRODUÇÃO	8
Setor: RECEBIMENTO/EXPEDIÇÃO	8
Cargo: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	8
Setor: VENDAS	8
Cargo: VENDEDOR	8
9. LISTA DE MÉDICOS EXAMINADORES	8
10. SUGESTÕES DE AÇÕES E METAS PARA QUALIDADE DE VIDA	8
11. CONSIDERAÇÕES FINAIS	9
12. DADOS MÉDICO COORDENADOR	9



PCMSO
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
CONAMORE SSL CAMA MESA E BANHO LTDA

31/01/2026

Vigência do PCMSO

JANEIRO/2026 A JANEIRO/2027

Identificação

Empresa
CONAMORE SSL CAMA MESA E BANHO LTDA

Endereço
Rua Plínio Pereira Neves, 33

Complemento

CNPJ
16.499.070/0002-57

CEP
13040-035

Cidade
Campinas

Bairro
Jardim do Trevo

UF
SP

CNAE
4755-5/03

Grau de Risco
1

Descrição CNAE
Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

1. INTRODUÇÃO

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) é um programa elaborado pelo médico do trabalho que integra um conjunto de ações de promoção à saúde dos trabalhadores, devendo estar articulado com as exigências das Normas Regulamentadoras (NR). Considera a relação entre a saúde e o trabalho e tem como prioridade a prevenção, o rastreamento e o diagnóstico precoce das doenças ocupacionais. A NR-7 estabelece a obrigatoriedade do PCMSO e objetiva monitorar, individualmente, aqueles trabalhadores expostos aos agentes químicos, físicos e biológicos e através disto promover e preservar a saúde destes. O PCMSO pode ser alterado a qualquer momento, no todo ou em parte, sempre que o Médico do Trabalho detectar mudanças nos riscos ocupacionais decorrentes de alterações nos processos de trabalho, novas descobertas da ciência médica, mudança de critérios de interpretação de exames ou ainda reavaliações do reconhecimento de riscos.

Este Programa foi elaborado de acordo com os seguintes textos legais:

Norma Regulamentadora nº 07 / NR - 07, aprovada pela Portaria nº 3214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.

2. OBJETIVO

7.1 OBJETIVO

7.1.1 Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece diretrizes e requisitos para o desenvolvimento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO nas organizações, com o objetivo de proteger e preservar a saúde de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais, conforme avaliação de riscos do Programa de Gerenciamento de Risco - PGR da organização.

Alem dos itens propostos na NR esse programa visa:

- * Contribuir para melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados aos clientes, através da preservação da saúde de seus trabalhadores;
- * Conscientizar o empregador e os empregados quanto à importância do aspecto preventivo para a manutenção da qualidade de vida dentro e fora da empresa;
- * Conscientizar os trabalhadores dos riscos existentes no seu ambiente de trabalho ou inerentes ao seu processo laboral;
- * Formar, através dos registros dos exames médicos ocupacionais, históricos de informações relativas às condições clínicas (físicas e mentais) dos colaboradores;
- * Normatizar e padronizar ações voltadas ao controle médico e de prevenção;
- * Indicar soluções para melhoria dos ambientes de trabalho e da sua organização das atividades, individuais e coletivamente, a partir da detecção de problemas;
- * Reduzir os índices de acidentes de trabalho, doenças profissionais e do trabalho;
- * Cumprir a legislação trabalhista e civil no que se refere à saúde do trabalhador

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

7.2 CAMPO DE APLICAÇÃO

7.2.1 Esta Norma se aplica às organizações e aos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário e ao Ministério Público, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

4. DIRETRIZES

7.3 DIRETRIZES

7.3.1 O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da organização no campo da saúde de seus empregados, devendo estar harmonizado com o disposto nas demais



NR.

7.3.2 São diretrizes do PCMSO:

- a) rastrear e detectar precocemente os agravos à saúde relacionados ao trabalho;
- b) detectar possíveis exposições excessivas a agentes nocivos ocupacionais;
- c) definir a aptidão de cada empregado para exercer suas funções ou tarefas determinadas;
- d) subsidiar a implantação e o monitoramento da eficácia das medidas de prevenção adotadas na organização;
- e) subsidiar análises epidemiológicas e estatísticas sobre os agravos à saúde e sua relação com os riscos ocupacionais;
- f) subsidiar decisões sobre o afastamento de empregados de situações de trabalho que possam comprometer sua saúde;
- g) subsidiar a emissão de notificações de agravos relacionados ao trabalho, de acordo com a regulamentação pertinente;
- h) subsidiar o encaminhamento de empregados à Previdência Social;
- i) acompanhar de forma diferenciada o empregado cujo estado de saúde possa ser especialmente afetado pelos riscos ocupacionais;
- j) subsidiar a Previdência Social nas ações de reabilitação profissional;
- k) subsidiar ações de readaptação profissional;
- l) controlar a imunização ativa dos empregados, relacionada a riscos ocupacionais, sempre que houver recomendação do Ministério da Saúde.

7.3.2.1 O PCMSO deve incluir ações de:

- a) vigilância passiva da saúde ocupacional, a partir de informações sobre a demanda espontânea de empregados que procurem serviços médicos; Este texto não substitui o publicado no DOU 3
- b) vigilância ativa da saúde ocupacional, por meio de exames médicos dirigidos que incluam, além dos exames previstos nesta NR, a coleta de dados sobre sinais e sintomas de agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais.

7.3.2.2 O PCMSO não deve ter caráter de seleção de pessoal.

5. RESPONSABILIDADES

7.4 RESPONSABILIDADES

7.4.1 Compete ao empregador:

- a) garantir a elaboração e efetiva implantação do PCMSO;
- b) custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO;
- c) indicar médico do trabalho responsável pelo PCMSO.

6. PLANEJAMENTO

7.5.1 O PCMSO deve ser elaborado considerando os riscos ocupacionais identificados e classificados pelo PGR.

7.5.2 Inexistindo médico do trabalho na localidade, a organização pode contratar médico de outra especialidade como responsável pelo PCMSO.

7.5.3 O PCMSO deve incluir a avaliação do estado de saúde dos empregados em atividades críticas, como definidas nesta Norma, considerando os riscos envolvidos em cada situação e a investigação de patologias que possam impedir o exercício de tais atividades com segurança.

7.5.4 A organização deve garantir que o PCMSO:

- a) descreva os possíveis agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR;
- b) contenha planejamento de exames médicos clínicos e complementares necessários, conforme os riscos ocupacionais identificados, atendendo ao determinado nos Anexos desta NR;
- c) contenha os critérios de interpretação e planejamento das condutas relacionadas aos achados dos exames médicos;
- d) seja conhecido e atendido por todos os médicos que realizarem os exames médicos ocupacionais dos empregados;
- e) inclua relatório analítico sobre o desenvolvimento do programa, conforme o subitem 7.6.2 desta NR.

7.5.5 O médico responsável pelo PCMSO, caso observe inconsistências no inventário de riscos da organização, deve reavaliá-las em conjunto com os responsáveis pelo PGR.

7.5.6 O PCMSO deve incluir a realização obrigatória dos exames médicos:

- a) admissional;

- b) periódico;
- c) de retorno ao trabalho;
- d) de mudança de riscos ocupacionais;
- e) demissional.

7.5.7 Os exames médicos de que trata o subitem 7.5.6 compreendem exame clínico e exames complementares, realizados de acordo com as especificações desta e de outras NR.

7.5.8 O exame clínico deve obedecer aos prazos e à seguinte periodicidade:

I - no exame admissional: ser realizado antes que o empregado assuma suas atividades;

II - no exame periódico: ser realizado de acordo com os seguintes intervalos:

a) para empregados expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR e para portadores de doenças crônicas que aumentem a susceptibilidade a tais riscos:

1. a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico responsável;
2. de acordo com a periodicidade especificada no Anexo IV desta Norma, relativo a empregados expostos a condições hiperbáricas;

b) para os demais empregados, o exame clínico deve ser realizado a cada dois anos

7.5.9 No exame de retorno ao trabalho, o exame clínico deve ser realizado antes que o empregado reassuma suas funções, quando ausente por período igual ou superior a 30 (trinta) dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não.

7.5.9.1 No exame de retorno ao trabalho, a avaliação médica deve definir a necessidade de retorno gradativo ao trabalho.

7.5.10 O exame de mudança de risco ocupacional deve, obrigatoriamente, ser realizado antes da data da mudança, adequando-se o controle médico aos novos riscos.

7.5.11 No exame demissional, o exame clínico deve ser realizado em até 10 (dez) dias contados do término do contrato, podendo ser dispensado caso o exame clínico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 135 (centro e trinta e cinco) dias, para as organizações graus de risco 1 e 2, e há menos de 90 (noventa) dias, para as organizações graus de risco 3 e 4.

7.5.12 Os exames complementares laboratoriais previstos nesta NR devem ser executados por laboratório que atenda ao disposto na RDC/Anvisa n.º 302/2005, no que se refere aos procedimentos de coleta, acondicionamento, transporte e análise, e interpretados com base nos critérios constantes nos Anexos desta Norma e são obrigatórios quando:

- a)** o levantamento preliminar do PGR indicar a necessidade de medidas de prevenção imediatas;
- b)** houver exposições ocupacionais acima dos níveis de ação determinados na NR-09 ou se a classificação de riscos do PGR indicar.

7.5.12.1 O momento da coleta das amostras biológicas deve seguir o determinado nos Quadros 1 e 2 do Anexo I desta NR.

7.5.12.2 Quando a organização realizar o armazenamento e o transporte das amostras, devem ser seguidos os procedimentos recomendados pelo laboratório contratado.

7.5.13 Os exames previstos nos Quadros 1 e 2 do Anexo I desta NR devem ser realizados a cada seis meses, podendo ser antecipados ou postergados por até 45 (quarenta e cinco) dias, a critério do médico responsável, mediante justificativa técnica, a fim de que os exames sejam realizados em situações mais representativas da exposição do empregado ao agente.

7.5.14 Para as atividades realizadas de forma sazonal, a periodicidade dos exames constantes nos Quadros 1 e 2 do Anexo I desta NR pode ser anual, desde que realizada em concomitância com o período da execução da atividade.

7.5.15 Os exames previstos no Quadro 1 do Anexo I desta NR não serão obrigatórios nos exames admissional, de retorno ao trabalho, de mudança de risco ocupacional e demissional.

7.5.16 Os empregados devem ser informados, durante o exame clínico, das razões da realização dos exames complementares previstos nesta NR e do significado dos resultados de tais exames.

7.5.17 No exame admissional, a critério do médico responsável, poderão ser aceitos exames complementares realizados nos 90 (noventa) dias anteriores, exceto quando definidos prazos diferentes nos Anexos desta NR.

7.5.18 Podem ser realizados outros exames complementares, a critério do médico responsável, desde que relacionados aos riscos ocupacionais classificados no PGR e tecnicamente justificados no PCMSO.

7.5.19 Para cada exame clínico ocupacional realizado, o médico emitirá Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, que deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado, devendo ser



fornecido em meio físico quando solicitado.

7.5.19.1 O ASO deve conter no mínimo:

- a) razão social e CNPJ ou CAEPF da organização;
- b) nome completo do empregado, o número de seu CPF e sua função;
- c) a descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no PGR que necessitem de controle médico previsto no PCMSO, ou a sua inexistência;
- d) indicação e data de realização dos exames ocupacionais clínicos e complementares a que foi submetido o empregado;
- e) definição de apto ou inapto para a função do empregado;
- f) o nome e número de registro profissional do médico responsável pelo PCMSO, se houver;
- g) data, número de registro profissional e assinatura do médico que realizou o exame clínico.

7.5.19.2 A aptidão para trabalho em atividades específicas, quando assim definido em Normas Regulamentadoras e seus Anexos, deve ser consignada no ASO.

7.5.19.3 Quando forem realizados exames complementares sem que tenha ocorrido exame clínico, a organização emitirá recibo de entrega do resultado do exame, devendo o recibo ser fornecido ao empregado em meio físico, quando solicitado.

7.5.19.4 Sendo verificada a possibilidade de exposição excessiva a agentes listados no Quadro 1 do Anexo I desta NR, o médico do trabalho responsável pelo PCMSO deve informar o fato aos responsáveis pelo PGR para reavaliação dos riscos ocupacionais e das medidas de prevenção.

7.5.19.5 Constatada ocorrência ou agravamento de doença relacionada ao trabalho ou alteração que revele disfunção orgânica por meio dos exames complementares do Quadro 2 do Anexo I, dos demais Anexos desta NR ou dos exames complementares incluídos com base no subitem

7.5.18 da presente NR, caberá à organização, após informada pelo médico responsável pelo PCMSO:

- a) emitir a Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT;
- b) afastar o empregado da situação, ou do trabalho, quando necessário;
- c) encaminhar o empregado à Previdência Social, quando houver afastamento do trabalho superior a 15 (quinze) dias, para avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária;
- d) reavaliar os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção pertinentes no PGR

7.5.19.6 O empregado, em uma das situações previstas nos subitens 7.5.19.4 ou 7.5.19.5, deve ser submetido a exame clínico e informado sobre o significado dos exames alterados e condutas necessárias.

7.5.19.6.1 O médico responsável pelo PCMSO deve avaliar a necessidade de realização de exames médicos em outros empregados sujeitos às mesmas situações de trabalho.

7. DOCUMENTAÇÃO

7.6 DOCUMENTAÇÃO

7.6.1 Os dados dos exames clínicos e complementares deverão ser registrados em prontuário médico individual sob a responsabilidade do médico responsável pelo PCMSO, ou do médico responsável pelo exame, quando a organização estiver dispensada de PCMSO.

7.6.1.1 O prontuário do empregado deve ser mantido pela organização, no mínimo, por 20 (vinte) anos após o seu desligamento, exceto em caso de previsão diversa constante nos Anexos desta NR.

7.6.1.2 Em caso de substituição do médico responsável pelo PCMSO, a organização deve garantir que os prontuários médicos sejam formalmente transferidos para seu sucessor.

7.6.1.3 Podem ser utilizados prontuários médicos em meio eletrônico desde que atendidas as exigências do Conselho Federal de Medicina.

7.6.2 O médico responsável pelo PCMSO deve elaborar relatório analítico do Programa, anualmente, considerando a data do último relatório, contendo, no mínimo:

- a) o número de exames clínicos realizados;
- b) o número e tipos de exames complementares realizados;
- c) estatística de resultados anormais dos exames complementares, categorizados por tipo do exame e por unidade operacional, setor ou função;
- d) incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, categorizadas por unidade operacional, setor ou função;
- e) informações sobre o número, tipo de eventos e doenças informadas nas CAT, emitidas pela organização, referentes a seus empregados;



f) análise comparativa em relação ao relatório anterior e discussão sobre as variações nos resultados.

7.6.3 A organização deve garantir que o médico responsável pelo PCMSO considere, na elaboração do relatório analítico, os dados dos prontuários médicos a ele transferidos, se for o caso.

7.6.4 Caso o médico responsável pelo PCMSO não tenha recebido os prontuários médicos ou considere as informações insuficientes, deve informar o ocorrido no relatório analítico.

7.6.5 O relatório analítico deve ser apresentado e discutido com os responsáveis por segurança e saúde no trabalho da organização, incluindo a CIPA, quando existente, para que as medidas de prevenção necessárias sejam adotadas na organização.

7.6.6 As organizações de graus de risco 1 e 2 com até 25 (vinte e cinco) empregados e as organizações de graus de risco 3 e 4 com até 10 (dez) empregados podem elaborar relatório analítico apenas com as informações solicitadas nas alíneas: a) e b) do subitem 7.6.2.

7.7 MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, MICROEMPRESA - ME E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

7.7.1 As MEI, ME e EPP desobrigadas de elaborar PCMSO, de acordo com o subitem 1.8.6 da NR01, devem realizar e custear exames médicos ocupacionais admissionais, demissionais e periódicos, a cada dois anos, de seus empregados.

7.7.1.1 Os empregados devem ser encaminhados pela organização, para realização dos exames médicos ocupacionais, a:

a) médico do trabalho; ou

b) serviço médico especializado em medicina do trabalho, devidamente registrado, de acordo com a legislação.

7.7.2 A organização deve informar, ao médico do trabalho ou ao serviço médico especializado em medicina do trabalho, que está dispensada da elaboração do PCMSO, de acordo com a NR-01, e que a função que o empregado exerce ou irá exercer não apresenta riscos ocupacionais.

7.7.3 Para cada exame clínico ocupacional, o médico que realizou o exame emitirá ASO, que deve ser disponibilizado ao empregado, mediante recibo, em meio físico, quando assim solicitado, e atender ao subitem 7.5.19.1 desta NR.

7.7.4 O relatório analítico não será exigido para:

a) Microempreendedores Individuais - MEI;

b) ME e EPP dispensadas da elaboração do PCMSO.

8. TABELA DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS

A tabela de exames médicos ocupacionais é onde todos os exames previstos estarão descritos, eles são estipulados a partir dos riscos ambientais/perigos que o colaborador está exposto, ou de acordo com os protocolos seguidos pelo médico e/ou empresa de medicina ocupacional

Para realizar a leitura da tabela de exames médicos ocupacionais é necessário entender alguns pontos básicos descritos abaixo:

Periodicidade é o tempo que o colaborador terá que realizar o exame novamente, ele é definido de acordo com a idade, tipo de exposição e parâmetros definidos na NR07 ou de acordo com o que o médico coordenador do PCMSO definir, geralmente os períodos são de 6, 12 e 24 meses, além da periodicidade padrão possui a periodicidade após admissão, onde ele terá que realizar o exame novamente no tempo determinado, geralmente de 6 meses, após ser admitido, depois desse período a periodicidade padrão volta

Tipo de exame aparecem na tabela como: Adm, Dem, Per, Rett, Mud, e sua obrigatoriedade varia de acordo com a situação por exemplo:

Adm / Admissional: Visa a perfeita adequação entre o indivíduo selecionado para uma determinada função, e a sua capacidade física e mental. Além da avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional e exame físico mental obrigatório em qualquer função, poderão ser realizados exames complementares;

Dem / Demissional: Julga se o trabalho exercido não trouxe prejuízos à sua saúde. O exame demissional deve constar de uma avaliação clínica, abrangendo exame físico e mental. A realização de exames complementares será definida pelos riscos presentes na atividade que era desenvolvida pelo trabalhador, encontrada na avaliação clínica e datas dos exames complementares realizados no último período;

Per / Periódico: Garante a mesma saúde ou ainda melhor do que aquela com a qual o indivíduo



ingressou na empresa. O exame poderá ser Bienal, Semestral e/ ou anual no que tange a avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional e exame físico e mental;

Rett / Retorno ao Trabalho: Avalia se a capacidade laborativa atual é a mesma a anterior preservando a integridade física e mental do empregado. O exame de retorno deve constar uma avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional, exame físico e mental. As realizações de exames complementares serão definidas pelos riscos presentes na atividade desenvolvida pela data dos últimos exames realizados e pelos da avaliação;

Mud / Mudança de Função/Risco: Deve ser realizado obrigatoriamente antes da data da mudança de função, sempre que ocorrer qualquer alteração da atividade, posto de trabalho ou de setor que implique na exposição do trabalhador a riscos diferentes daqueles a que estava exposto antes da mudança. O exame de mudança de função deve constar de uma avaliação clínica, abrangendo exame físico e mental. A realização de exames complementares será definida pelos riscos presente na nova atividade a ser desenvolvida, tendo como orientação as funções listadas no Admissional e pelos achados da anamnese da avaliação clínica.

Todas as informações contidas nessa tabela serão as mesmas informações que irão aparecer no ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

Unidade: CONAMORE SSL CAMA MESA E BANHO LTDA

Setor: GERÊNCIA/PRODUÇÃO

Cargo: GERENTE DE SUPRIMENTOS		Nº de Funcionários	
Perigo / Fator de Risco		Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1	
		Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde	
POSTURAS INCOMODAS	Ergonômicos	Em indivíduos mais suscetíveis, a exposição ao agente de risco, pode ocasionar dor na região lombar e dores de cabeça. Não são esperadas doenças crônicas em curta frequência e tempo de exposição.	
INCÊNDIO	Acidente	Queimaduras, lesões graves e morte.	
QUEDA DE MESMO NÍVEL	Acidente	Lesões pelo corpo.	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
AVALIAÇÃO DA ACUIDADE VISUAL	X		12 meses		X	
EXAME CLINICO	X		12 meses	X	X	X

Setor: PRODUÇÃO-CORTE DE TECIDOS

Cargo: CORTADOR		Nº de Funcionários	
Perigo / Fator de Risco		Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1	
		Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde	
LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS OU VOLUMES	Ergonômicos	A má condução de pesos pode causar lesões musculoesqueléticas, que afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos, ossos e doenças localizadas no aparelho circulatório.	
POSTURAS INCOMODAS	Ergonômicos	Em indivíduos mais suscetíveis, a exposição ao agente de risco, pode ocasionar dor na região lombar e dores de cabeça. Não são esperadas doenças crônicas em curta frequência e tempo de exposição.	
INCÊNDIO	Acidente	Queimaduras, lesões graves e morte.	
QUEDA DE MESMO NÍVEL	Acidente	Lesões pelo corpo.	

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
AVALIAÇÃO DA ACUIDADE VISUAL	X		12 meses		X	
EXAME CLINICO	X		12 meses	X	X	X
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	X		24 meses		X	X

Setor: PRODUÇÃO-COSTURA



PCMSO
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
CONAMORE SSL CAMA MESA E BANHO LTDA

31/01/2026

Cargo: COSTUREIRA
Perigo / Fator de Risco

POSTURAS INCOMODAS

INCÊNDIO
 QUEDA DE MESMO NÍVEL

Grupo

Ergonômicos

Acidente
Acidente

Nº de Funcionários

Masc.: 1 Fem.: 4 Menor: 0 Total: 5

Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde

Em indivíduos mais suscetíveis, a exposição ao agente de risco, pode ocasionar dor na região lombar e dores de cabeça. Não são esperadas doenças crônicas em curta frequência e tempo de exposição.

Queimaduras, lesões graves e morte.

Lesões pelo corpo.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
AVALIAÇÃO DA ACUIDADE VISUAL	X		12 meses		X	
EXAME CLÍNICO	X		12 meses	X	X	X

Sector: PRODUÇÃO-REVISÃO E EMPACOTAMENTO

Cargo: AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Perigo / Fator de Risco

POSTURAS INCOMODAS

INCÊNDIO
 QUEDA DE MESMO NÍVEL

Grupo

Ergonômicos

Acidente
Acidente

Nº de Funcionários

Masc.: 0 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 0

Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde

Em indivíduos mais suscetíveis, a exposição ao agente de risco, pode ocasionar dor na região lombar e dores de cabeça. Não são esperadas doenças crônicas em curta frequência e tempo de exposição.

Queimaduras, lesões graves e morte.

Lesões pelo corpo.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
AVALIAÇÃO DA ACUIDADE VISUAL	X		12 meses		X	
EXAME CLÍNICO	X		12 meses	X	X	X

Cargo: REVISOR(A)
Perigo / Fator de Risco

POSTURAS INCOMODAS

INCÊNDIO
 QUEDA DE MESMO NÍVEL

Grupo

Ergonômicos

Acidente
Acidente

Nº de Funcionários

Masc.: 0 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 0

Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde

Em indivíduos mais suscetíveis, a exposição ao agente de risco, pode ocasionar dor na região lombar e dores de cabeça. Não são esperadas doenças crônicas em curta frequência e tempo de exposição.

Queimaduras, lesões graves e morte.

Lesões pelo corpo.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
AVALIAÇÃO DA ACUIDADE VISUAL	X		12 meses		X	
EXAME CLÍNICO	X		12 meses	X	X	X

Sector: QUALIDADE

Cargo: LÍDER DE PRODUÇÃO
Perigo / Fator de Risco

POSTURAS INCOMODAS

INCÊNDIO
 QUEDA DE MESMO NÍVEL

Grupo

Ergonômicos

Acidente
Acidente

Nº de Funcionários

Masc.: 0 Fem.: 1 Menor: 0 Total: 1

Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde

Em indivíduos mais suscetíveis, a exposição ao agente de risco, pode ocasionar dor na região lombar e dores de cabeça. Não são esperadas doenças crônicas em curta frequência e tempo de exposição.

Queimaduras, lesões graves e morte.

Lesões pelo corpo.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
--------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------	----------



PCMSO
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
CONAMORE SSL CAMA MESA E BANHO LTDA

31/01/2026

AVALIAÇÃO DA ACUIDADE VISUAL	X	12 meses	X	
EXAME CLINICO	X	12 meses	X	X

Setor: RECEBIMENTO/EXPEDIÇÃO

Cargo: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Perigo / Fator de Risco

Grupo

Nº de Funcionários

Masc.: 1 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde

LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS OU VOLUMES

Ergonômicos

A má condução de pesos pode causar lesões musculoesqueléticas, que afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos, ossos e doenças localizadas no aparelho circulatório.

POSTURAS INCOMODAS

Ergonômicos

Em indivíduos mais suscetíveis, a exposição ao agente de risco, pode ocasionar dor na região lombar e dores de cabeça. Não são esperadas doenças crônicas em curta frequência e tempo de exposição.

INCÊNDIO

Acidente

Queimaduras, lesões graves e morte.

QUEDA DE MESMO NÍVEL

Acidente

Lesões pelo corpo.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
AVALIAÇÃO DA ACUIDADE VISUAL	X		12 meses		X	
EXAME CLINICO	X		12 meses	X	X	X
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	X		24 meses		X	X

Setor: VENDAS

Cargo: VENDEDOR

Perigo / Fator de Risco

Grupo

Nº de Funcionários

Masc.: 0 Fem.: 0 Menor: 0 Total: 0

Descrições dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde

POSTURAS INCOMODAS

Ergonômicos

Em indivíduos mais suscetíveis, a exposição ao agente de risco, pode ocasionar dor na região lombar e dores de cabeça. Não são esperadas doenças crônicas em curta frequência e tempo de exposição.

INCÊNDIO

Acidente

Queimaduras, lesões graves e morte.

QUEDA DE MESMO NÍVEL

Acidente

Lesões pelo corpo.

Exames	ADMISSÃO	APÓS ADM.	PERIÓDICO	RET. TRAB	MUD. RISCOS	DEMISSÃO
AVALIAÇÃO DA ACUIDADE VISUAL	X		12 meses		X	
EXAME CLINICO	X		12 meses	X	X	X

9. LISTA DE MÉDICOS EXAMINADORES

Acesse o link abaixo para realizar o acesso da lista de médicos examinadores:

Link de

acesso: <http://docs.google.com/document/d/1sIrtT7CFuiuaE9ByJ0aUOEtIUHNTdJLM/edit?usp=sharing&ouid=112997794140932927525&rtpof=true&sd=true>

10. SUGESTÕES DE AÇÕES E METAS PARA QUALIDADE DE VIDA

Sugestões para ações e metas voltadas para saúde e qualidade de vida.

1. Orientação sobre IST ? INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS.
2. Orientação a respeito de - DIABETE.
3. Orientação a respeito de - HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA.
4. Orientação a respeito de - MALEFÍCIO PROVOCADO PELA OBESIDADE.
5. Orientação a respeito de prevenção de - CÂNCER GINECOLÓGICO.
6. Orientação a respeito de prevenção de - CÂNCER DE MAMA.
7. Orientação a respeito de prevenção de - CÂNCER DE PRÓSTATA.
8. Orientação a respeito de prevenção da - OSTEOPOROSE.
9. Orientação a respeito de prevenção da - SAÚDE MENTAL.
10. Campanhas contra a - VIDA SEDENTÁRIA E SEUS MALEFÍCIOS.

11. Campanha contra o - ÁLCOOL.
12. Campanha contra o - TABAGISMO.
13. Campanha contra a - DEPENDÊNCIA QUÍMICA.

Promover tais ações dentro do ambiente corporativo impacta diretamente na produtividade e qualidade de vida, reduzindo absenteísmo e melhorando o clima organizacional

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este documento PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, fora elaborado pelo MÉDICO COORDENADOR DO PCMSO.

Na elaboração desse documento foram considerados todos os riscos (físico, químico, biológico, ergonômicos e acidentes) com base nas principais NR(s): 1, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 33, 35 e futuras atualizações de novas e atuais normas, conforme levantamentos de riscos realizados no PGR, foram observados as concentrações e intensidade dos riscos. Consideramos nesse documento somente as medições acima do limite de tolerância (nível de ação) por questões legais médicas de avaliação clínica.

12. DADOS MÉDICO COORDENADOR



CRM: 83879
Nome: RONYVALDO DE GODOY BUENO
Situação: Ativo
Endereço: Divulgação não autorizada
Telefone: Divulgação não autorizada
E-mail: Divulgação não autorizada

Especialidade/Área de atuação	RQE
MEDICINA DO TRABALHO	62610



RONYVALDO DE GODOY BUENO
Médico responsável pelo PCMSO
CRM: 83879/SP
CPF: 151.532.298-07
Especialidade: Medicina do Trabalho

CONAMORE SSL CAMA MESA E BANHO 0002-57